

הפרעות הפסיכיאטריות

חלקי הנפש

אפשר לחלק את הנפש לשלושה חלקים עיקריים:

- **החלק הקוגניטיבי, החשיבתי** - הכולל בין היתר את ההכרה,* ההתמצאות, הריכוז והחשיבה;
- **החלק הרגשי** - הכולל בין היתר את מצב הרוח על פי הנבדק, שהוא האפקט (affect) - מצב הרוח של הנבדקים כפי שהוא נצפה על ידי הבודקים;
- **החלק התפקודי** - כיצד הנבדק מתפקד מבחינה נפשית.

ההפרעות הפסיכיאטריות

אפשר לחלק את ההפרעות הפסיכיאטריות בצורות שונות:

- הפרעות מסיבה אורגנית-מוחית, למשל הרעלת סמים, לעומת הפרעות פונקציונליות שסיבתן המוחית אינה ידועה, למשל הסכיזופרניה.

« איך נדע אם הפרעה היא אורגנית? במקרים אלה נמצא כמעט תמיד גם הפרעה בהכרה.

- הפרעות שהלוקים בהן מודעים לקיומן לעומת הפרעות שאין אליהן מודעות אגודיסטוניות לעומת אגודיסטוניות. אגודיסטוניות, העצמי, והפרעה אגודיסטונית מנוגדת לתחושת העצמי, ולהפך. לדוגמה: פוביה/חרדה מגורם מסוים נחשבת להפרעה אגודיסטונית; מצב פסיכוטי נחשב למצב שבו אין מודעות למציאות, ולכן ההפרעה היא אגודיסטונית.

« איך נבדיל בין המצבים? מי שמודע לבעייתו לא יתכחש לה, וגם ירצה לטפל בה. מי שאינו מודע - לא ישנה את דעתו בשום אופן.

- מחלות נפש/ הפרעות פסיכוטיות לעומת הפרעות נזירותיות והפרעות אישיות:

בכל מחלות הנפש נמצא הפרעה בביקורת המציאות - לדוגמה: במחלת הסכיזופרניה יש שכחות של מחשבות שווא (דלוזיות) = מחשבות שווא, מחשבות לא מציאותיות, כמו "אני המשיח", "חייזרים רודפים אחריי", ותחושות שווא (הלוצינציות שמיעה או ראייה. בהלוצינציות שמיעה שומעים קולות שאינם קיימים ובהלוצינציות ראייה רואים מראות שאינם קיימים); במחלות האפקטיביות (מחלות מצב הרוח) כמו דיכאון רבא (major depression) והמחלה הדוֹקטבית (בשמה הישן מאניה דפרסיבית) נמצא **הפרעה בביקורת המציאות של הרגש**: הדיכאון (הקליני) או היפוכו - המאניה - יהיו לא מציאותיים.

בהפרעות הנזירותיות - נמצא **מודעות להפרעה וביקורת מציאות תקינה**. ברוב ההפרעות הנזירותיות מופיעה חרדה והלוקים בה מודעים לקיומה ומעוניינים לטפל בה. דוגמאות: פוביה (פחד לא הגיוני) מסוגים שונים כמו: אגורפוביה (פחד ממקומות ציבוריים), קלאוסטרופוביה (פחד ממקומות סגורים), אקרופוביה (פחד גבהים).

הפרעות אישיות - מאופיינות במבנה אישיות קבוע הגורם **להפרעה תפקודית** שממנה סובלים הלוקים בהן או סביבתם. אין מדובר בתכונות אונטיות האישיות, הקיימות אצל כל אחד, אלא במבנה נוקשה קבוע הפוגע בתפקוד האישי או הבין-אישי. לדוגמה: בהפרעת אישיות נרקסיסטית (narcissism) - אין

* כאשר יש פגיעה במצב ההכרה - יש לחשוד תמיד בהפרעה אורגנית-מוחית, כלומר שאין מדובר בבעיה פסיכיאטרית טהורה, ויש לחפש מהו הגורם המשפיע על המוח (תרופות, חומרים ממכרים, מצבים גופניים שונים, וכד.).

מדובר בגאווותנות או בביטחון עצמי מופרז אלא בצורך קבוע בהערכה והערצה. אם צרכים אלה אינם מתגשמים, הנרקיסים יישברו ויפסיק לתפקד. בהפרעות אישיות ביקורת המציאות תקינה, אך ההפרעה היא אגורסיבטונית (הם אינם סבורים שיש להם בעיה).

אין לאבחן הפרעה נפשית אם לא מאבחנים הפרעה בתפקוד.

חלוקה מעשית עבור רפואת החירום הטרום-אשפוזית:

- « חשוב לזהות מקרים של הפרעות מסיבה אורגנית-מוחית כדי למנוע מוות או נכות. במקרים אלה נמצא כמעט תמיד גם שינוי במצב ההכרה.
- « חשוב לזהות מצבים שבהם יש הפרעה בביקורת המציאות - מדובר במצבים של מחלת נפש, ואין לצפות לשיתוף פעולה מהנבדק.
- « במקרים אלה אפשר לטפל בנבדקים גם ללא הסכמתם, לפי חוק הטיפול בחולי הנפש.

מצבי החירום בפסיכיאטריה: הגדרות

מצבי החירום העיקריים בפסיכיאטריה הם כל המצבים הכוללים הפרעה בחשיבה, ברגשות או בהתנהגות הדורשים התערבות טיפולית מיידי. עד כה מקום הבדיקה והטיפול הראשוני היה בדרך כלל בחדר המיון הכללי. הטיפול במצב החירום כולל: אבחנה ראשונית, זיהוי הגורמים המיידיים והתחלת טיפול דחוף - או הפניית המטופל למתקן מתאים יותר.

הנקודות המרכזיות בהערכת מצב החירום הן:

- **האם הגורם אורגני או פונקציונלי?** - לעיתים זו הקביעה החשובה ביותר בחדר המיון. בין הגורמים למצבים מסכני חיים: הרעלות, סמים, אלכוהול, גמילה, מחלות אנדוקריניות, SDIA, חבלות ראש.
- **האם יש מצב פסיכוטי?** - במצב פסיכוטי לנבדק אין ביקורת מציאות והוא עלול לסבול ממחשבות שווא (דלוזיות) ומתחושות שווא (הלוצינציות). מצב כזה עלול להקשות מאוד על הבדיקה, ולכן תוצאותיה יהיו לא אמינות. במקרה זה נחוצה אנמנזה קולטורלית כדי לקבל תמונת מצב של ההפרעה מגורם המכיר היטב את הנבדק, בדרך כלל בן משפחה קרוב. כמו כן, נבדק עם מחשבות שווא של רדיפה עלול לפרש את הבדיקה כתקיפה, ולכן תהיה בעיה קשה בהיענות לטיפול.
- **האם הנבדק אובדני או מסוכן לאחרים?** - הסיבה העיקרית לבדיקות הפסיכיאטריות בחדרי מיון כלליים היא להעריך אם יש סכנה אובדנית או מסוכנת לאחרים. חשוב להביא בחשבון שאלומות כלפי הבודקים עלולה להיגרם גם מתפיסה מוטעית של הנבדק את התנהגות הצוות.
- **האם הנבדק מסוגל לדאוג לעצמו?** - זוהי נקודה חשובה מבחינה משפטית, והיא חיונית לגבי המלצות להמשך הטיפול.

מטרות העזרה הראשונה הנפשית

העזרה הראשונה הנפשית נכללת למעשה בעזרה הראשונה הרפואית והיא חלק בלתי נפרד ממנה. לפיכך, צוותי רפואה והצלה מחויבים לדעת אותה.

מטרות העזרה הראשונה הנפשית הן רבות: תחילה, להקל על הנפגעים, בעיקר על ידי הפחתת רמת החרדה שלהם; נוסף על כך: לאפשר טיפול מיטבי עבור נפגעים הסובלים מפגיעה או ממחלה, שסובלים גם מבעיה נפשית (גם כאן בדרך כלל אפשר טיפול בחרדה); ולצד זאת, למנוע התפתחות תסמונות נפשיות ממושכות, כגון הפרעה פוסט־טראומטית, שעלולה להתפתח בעקבות תגובה נפשית לאירועים קשים, וכן למנוע החרפה במצבם הנפשי של הסובלים מהפרעות נפשיות.

צוותי מד"א מטפלים בקביעות בנפגעי חרדה. למעשה, כמעט כל טיפול הניתן על ידי הצוותים המטפלים של מד"א כולל הרגעת המטופלים, מתן הרגשת ביטחון ביכולות הטיפול של הצוות ונטיעת תקווה להחלמה. במקרים שבהם חרדתם של המטופלים בולטת נדרשים הצוותים לטפל בחרדה כחלק מהותי בטיפול.

בכל שלב של ההתערבות הטיפולית אין לשלול את האפשרות שהמצב הנפשי נגרם מפגיעה גופנית או הפרעה גופנית/מוחית. לכן, יש לערוך לכל נפגע בדיקה גופנית על סמך סיפור הפגיעה.

גם מטופלים שנפגעו פגיעה גופנית עלולים לפתח מצב של חרדה כחלק מהפגיעה.

הקשר הטיפולי: הגורם הראשי בטיפול הנפשי גם בשעת חירום

קשר טוב בין מטפלים למטופלים חיוני בכל טיפול רפואי. ואולם - חשיבותו במתן טיפול נפשי מהותית, ובמרבית המקרים הוא גורם טיפולי חיוני והכרחי.

הבנת המטופלים כי המטפלים משקיעים בטיפול בהם את מיטב יכולתם המקצועית מתוך רצון לסייע להם והרגשתם את הגישה האמפתית של המטפלים - כלומר את יכולת המטפלים להבין את מצוקותיהם - כל אלו נקראות בין היתר קשר טיפולי, ברית טיפולית וכן גורמים בלתי ספציפיים בריפוי הנפשי. אין לטעות ולהניח כי מדובר בטיפול מסוג פלצבו (אינבו) בלבד, מאחר שיעילות הקשר הטיפולי בריפוי ההפרעות הנפשיות הוכחה בניסויים רבים, כולל בניסויים תרופתיים. למשל במחקרים של תרופות נוגדות דיכאון אפשר למצוא כי השפעת הקשר הטיפולי עולה לעיתים על השפעת התרופה הפסיכיאטרית.

אמפתיה היא היכולת לראות את נקודת המבט של הזולת ולתת לו את ההרגשה שאנחנו מבינים כיצד הוא מרגיש.

בהקשר טיפולי אמפתיה היא יצירת ההבנה של המטופלים שאנו המטפלים מסוגלים "להיכנס לעורם", להרגיש את כאבם, חרדתם - לא מתוך הזדהות, רחמים או חברות אלא כגורם מקצועי.

חלק מהצלחת הטיפול הנפשי נובע גם מהרגשת המטופלים שהם נמצאים בטיפול מקצועי, של גורם מטפל סמכותי. לכן גם מתנדבים מגישי עזרה ראשונה המזוהים כאנשי צוות מד"א הם מבחינה זאת גורמים מקצועיים, ולקבלת יחס מרגיע מהם בזמן חירום תהיה השפעה משמעותית.

מתן טיפול מקצועי ואמפתי על ידי צוותי מד"א, בשגרה ובחירום, יוצר קשר טיפולי חיובי. אין לדחות פעולות מצילות חיים כדי לבסס קשר זה, אך גם במצבי חירום יש לזכור כמה חשוב שתציגו את עצמכם בפני המטופלים בשמכם ובתפקידכם, ועד כמה חשוב שתבהירו את תמונת המצב החיונית למטופלים באמפתיה - ככל שמצב החירום מאפשר.

בהיעדר אמצעי טיפול כגון תרופות הרגעה, הקשר הטיפולי הוא בסיס להרגעת המטופלים. הכלי הטיפולי המרגיע והמעודד העיקרי בשעת חירום הוא בהחלט אתם, אנשי הצוות.

יצירת קשר טיפולי מיידי בעת בדיקת המטופלים והנפגעים

בדיקת מצבם הנפשי של המטופלים והנפגעים היא חלק בלתי נפרד מהערכת מצבם הרפואי. כבר בבדיקה הגופנית הראשונית, בכל רמת בדיקה, יש לשים לב למצב הנפשי ואת זאת יש לעשות בגישה מעודדת ואמפתית.

כדי ליצור קשר טיפולי חיובי יש להקפיד ככל האפשר על פרטיותם של הנבדקים, וכן לשוחח עימם כשווים אל שווים. יש להתאים את השאלות למצב הנבדקים ולגילם. כמו כן, חשוב שבדיקת ילדים תיעשה בנוכחות הוריהם, במידת האפשר, לפי הסיטואציה. הבדיקה הנפשית של ילדים מתחילה ביצירת הקשר הטיפולי - כדי לאפשר את עצם הבדיקה.

שלבי יצירת הקשר הטיפולי

במידת האפשר, יש לפעול לפי סדר זה:

- 1) הציגו עצמכם בפני הנפגע: בשמכם ובתפקידכם
- 2) הביעו התחייבות לסייע לו
- 3) נסו לנהל את המפגש בגובה העיניים: בישיבה ובעמידה או בהליכה משותפת, אם אין מדובר באדם עם פגיעה גופנית
- 4) הימנעו מעימותים עם הנפגע
- 5) מסרו משוב תומך במפגש

חלקים מרכזיים בבדיקה הפסיכיאטרית

בדיקת מצב הכרה - בכל מקרה מבררים את מצב ההכרה וההתמצאות של האדם: בזהות (של עצמו ושל הסובבת), בזמן ובמקום. שינויים במצב ההכרה, כמו בלבול והכרה מעורפלת, המלווים באי-התמצאות בזהות (של הנבדק או של אחרים בסביבה), או אי-התמצאות בזמן ובמקום, כל אלה מכוונים לבעיה אורגנית-מוחית.

« כיצד מבררים זאת? שואלים את הנבדק לשמו, מבררים אם הוא יודע מה התאריך, איזה יום היום, היכן הוא נמצא ומי הסובבים אותו; כל זאת בגישה אוהדת ולא פוגענית.

בדיקת מצב הרוח, האפקט - מבררים מה מצב הרוח (האפקט) של הנבדק. דיכאון ניכר יכול לכוון לסכנה אובדנית. מצב הפוך - מאניה, יכול גם הוא להעיד על בעיה נפשית חמורה. גם מצב רוח שאינו תואם את המציאות (אפקט לא תואם) יכול להעיד על בעיה נפשית ניכרת.

« כיצד מבררים זאת? אפשר לשאול זאת ישירות, אך בדרך כלל מתוך השיחה עם הנבדק אפשר להבין מה מצב רוחו ואם מצב הרוח תואם את הסיטואציה שבה הוא נמצא.

הערכת סכנה אובדנית - הערכת סכנה אובדנית היא חלק הכרחי בבדיקה הנפשית. אם עולה חשד כזה, אין לחשוש לשאול את הנבדק שאלה ישירה: "האם ניסית להתאבד או חשבת על כך?". יש לשאול באמפתיה, תוך שמירה על פרטיות הנשאל. בדרך כלל אם התשובה חיובית, שיחה אוהדת על מצוקות הנבדק שהביאו למחשבה האובדנית תביא להקלה בהרגשתו.

בהערכה הפסיכיאטרית המלאה שלילת אובדנות היא חלק מהבדיקה, אף אם לא עולה לכך חשד.

בדיקת ביקורת המציאות - מבררים אם יש לנבדק ביקורת מציאות תקינה: אם אין לו מחשבות שווא או תחושות שווא, המאפיינות מצבים פסיכיים. מחשבות שווא יכולות להיות למשל של תחושת רדיפה (מחשבה שמנסים לפגוע בנבדק, ללא קשר עם המציאות), מחשבות של גדלות (המטופל רואה עצמו כדמות חשובה, למשל המשיח). תחושות שווא יכולות להיות שמיעת קולות שאינם קיימים, ראיית מראות שאינם קיימים וכדומה.

« כיצד מבררים זאת? במקרים אלה על המטפל לסמוך על ההיגיון. גם אם המטפל משוכנע שלנבדק יש מחשבות שווא, אין להתווכח או לנסות לשכנעו שהוא טועה, מאחר שהדבר עלול לפגוע בקשר הטיפולי. אם הנבדק מתעקש לנסות לשכנע שהוא צודק ולמשל שהוא המשיח ועל הבודקים להכיר בכך ולהאמין בו, על המטפל להגיב באמירה כגון: "אני מאמין שאתה משוכנע שאתה המשיח".

בדיקת המודעות העצמית - בכל מקרה יש לבדוק את מידת המודעות העצמית של הנבדק למצבו הגופני והנפשי. אם הנבדק אינו מודע למצבו, מצב הבדיקה והטיפול נעשה רגיש ואף מסובך ועולה עד מאוד חשיבותו של הקשר הטיפולי המידי הטוב.

« כיצד בודקים זאת? לדוגמה על ידי השאלה (בהקשר המתאים) "האם לדעתך יש לך בעיה?"

בדיקה פסיכיאטרית מלאה מבוצעת על ידי בודקים מתחום מקצועות בריאות הנפש, וגם היא מלווה בבדיקה גופנית מלאה, עם דגש על הבדיקה הניירולוגית.
לכן, אם יש חשש להפרעה נפשית חמורה יש לשאוף להביא את הנבדק לבדיקה כזאת.

הרגעת נפגעים במצבי חרדה

אם הנפגע ממשיך להראות סימני חרדה שאינה מאפשרת את הטיפול, אפשר להרגיע אותו באופן התנהגותי. הטיפול ההתנהגותי מבוסס על ההיגיון שאי אפשר להיות רגוע וחרד בעת ובעונה אחת. לכן, יצירת מצב של רגיעה גופנית תביא בהכרח לרגיעה נפשית. את הרגיעה הגופנית משיגים על ידי טכניקות שונות, שהמשותף לכולן הוא האטת הנשימה על ידי נשימה איטית ועמוקה.

זהו הבסיס לכל טיפול התנהגותי, וגם לכל הטיפולים הקוגניטיביים-התנהגותיים (CBT: cognitive behavioral therapy), שהם הטיפולים המובילים כיום בטיפול בהפרעות רבות כולל PTSD, הפרעות חרדה אחרות ודיכאון.

הכלל הראשון: חפשו בעיה גופנית (הגורמת למצב הנפשי)

בכל הערכה של מצב חירום נפשי יש חשיבות עליונה לשלילת גורם גופני או אורגני למצב הנפשי, מאחר שכל מצב כזה משמעו פגיעה בתפקוד המוח, שעלולה להיות קטלנית או לגרום לנכות. כאשר מדובר בפגיעה מוחית הגורמת לסימפטומים נפשיים מדובר בהפרעה מסוכנת ביותר, שעלולה להידרדר אף למוות או להסתיים בנכות מוחית קבועה. מסיבות אלה, אפשר לראות בפסיכיאטרים הבודקים בחדרי המיון את "קו העמדות האחורי" לשלילת גורמים אורגניים-מוחיים במצבי חירום פסיכיאטריים.

בכל מצב של פגיעה תפקודית מוחית שנגרמת מהפרעה אורגנית ישירה של המוח (הרעלה, פגיעה מטבולית, זיהום, טראומה וכדומה), אפשר לזהות בדרך כלל שינוי מסוים במצב ההכרה: החל מבלבול וכלה באיבוד הכרה מוחלט. עם זאת יש לזכור כי מצב חירום גופני יכול להיות גם גורם לחרדה (פחד, בהלה ללא סיבה ברורה), למשל חרדת מוות בעת התקף לב; פגיעות גופניות שיכולות להתבטא בסימנים המדמים מצב של חרדה: איבוד דם (חיצוני או פנימי) יכול לגרום לירידת לחץ הדם, לטשיקרידה, לחיזור ולטכיפניה - שכולם יכולים להיות סימנים של חרדה. לכן, במקרים שבהם יש חשד לפגיעה גופנית שיכולה להידמות למצב חרדה - קודם כול מחפשים סיבה גופנית.

סדר הפעולות בבדיקת הנפגע שנראה כסובל מפגיעה נפשית, לרבות חרדה, זהה לחלוטין לזה של בדיקת הנפגע שיש לו פגיעה גופנית, עד לשלב שבו נשללת פגיעה גופנית, כולל פגיעה אורגנית-מוחית. במקרים שבהם הנפגע היה חשוף להדף יש להתייחס אליו כמי שעלול לסבול מדימום פנימי - עד להגעתו לחדר מיון, לשלילת אבחנה כזאת. כך גם במקרים שבהם יש חשד לפגיעה אורגנית-מוחית, כמו הרעלה מחומרים שונים כולל סמים.

גם כאב פיזי, לאחר חבלה למשל, עלול להקשות על הנפגע להירגע. יש להביא בחשבון שפעולות פשוטות כמו קיבוע איבר פגוע ומתן נוגדי כאבים - עשויות להרגיע את המטופל במידה ניכרת ולהקל עליו.

פגיעות גופניות כמצבי משבר

צוותי מד"א מטפלים דרך קבע במצבים גופניים הנגרמים ממחלות ומתאונות, מצבים שהם עבור הנפגעים מצבי משבר. לכן יש להתייחס למי שסובל מהתקף לב, למשל, או למי שנפצע פציעה חמורה בתאונה על פי גישה זו. גם מוות של בן משפחה קרוב הוא משבר עבור בני המשפחה הנוכחים במקום, וגם אליהם צוותי מד"א צריכים להתייחס לפי גישה זו.

הרגעת המטופל הפסיכיאטרי הסוער

מצב סוער אצל הסובלים מהפרעות נפשיות מחייב התייחסות טיפולית מיידית ויכול להיות אתגר לצוות מד"א. הגישה המקובלת כיום היא לנסות להימנע מטיפול כפוי כמו קשירה ומתן טיפול תרופתי כפוי, ולעומת זאת - יש לנסות להרגיע את המטופלים ללא כפייה. שימוש בשיטות טיפול ללא כפייה על ידי צוותים מיומנים, יכול להביא לתוצאות מיטביות. להלן המלצות של צוות חשיבה מטעם ארגון הפסיכיאטרים האמריקאים, להרגעה (דה-אסקלציה) של מטופלים פסיכיאטריים סוערים:

הגישה למטופל כוללת שלושה שלבים:

- פנייה מילולית
- יצירת יחסי שיתוף פעולה
- הרגעה מילולית.

הרגעה מילולית זאת, המשולבת בשיתוף פעולה של המטופל, היא בדרך כלל המפתח להפיכתו לשותף פעיל בהערכת מצבו הרפואי ובטיפול בו. כך גם לגבי תכנון המשך הטיפול ולגבי טיפול תרופתי - רצוי שהוא ייתן בהסכמת המטופל.

לטיפול במטופל הפסיכיאטרי הסוער ארבע מטרות:

- (1) להבטיח את שלומם של המטופל, הצוות ואנשים אחרים הנמצאים במקום
- (2) לסייע למטופל להשיג שליטה רגשית והתנהגותית
- (3) להימנע ככל האפשר מהגבלות כגון קשירה
- (4) להימנע ככל האפשר מהפעלת טיפול כפוי שעלול לגרום להחרפת המצב הסוער

ההנחיות לגישה למטופל הסוער כוללות 10 המלצות (שהן נכונות גם עבור כל מטופל):

- (א) כבדו את המרחב של המטופל
- (ב) אל תהיו פרובוקטיביים
- (ג) צרו קשר מילולי
- (ד) היו מדויקים
- (ה) זהו רצונות ורגשות
- (ו) האזינו היטב לדברי המטופל
- (ז) הסכימו או הסכימו שלא להסכים
- (ח) הסבירו את כללי ההתנהגות ושימו גבולות ברורים למטופל
- (ט) הציעו ברירות והביעו תקווה
- (י) תדרכו את המטופל ואת הצוות

מצבי חירום בהתמכרויות

מצבי החירום הקשורים לשימוש בחומרים ממכרים מופיעים בדרך כלל בהרעלות ובגמילה, וגם בעקבות שימוש ממושך בחומרים אלה. אפשר לחלק מצבים אלה גם למצבי חירום גופניים ולמצבי חירום פסיכיאטריים.

יש לזכור שחלק ניכר מהמשתמשים והמכורים, משתמשים בכמה חומרים שונים, ולכן להשלמת הבירור יש תמיד לבדוק את פרופיל הסמים בדם ובשתן.